

SANTÉ MENTALE — PSYCHIATRIE

Fiches QE Haute Fréquence — Analyse de 750 questions d'examen — Version 1

Cross-match : 750 QEs officielles (Janvier 2018 → Normal 2026) × Cours AIO Santé Mentale 2025-2026 (1212 diapositives)

Pr Manoudi · Pr Ag M.A. Laffinti · Pr I. Adali — FMPM 2026

PARTIE 1 — CLASSEMENT DES LEÇONS PAR ORDRE D'IMPORTANCE

Classement basé sur la fréquence réelle dans 750 QEs (15 sessions).

Rang	Leçon officielle	Total	Professeur
1	Thérapeutique (psychotropes)	116 Q	Pharmacologie / Psychiatrie
2	Patient qui délire (APA, schizophrénie, délires chroniques, hystérie)	101 Q	—
3	Dépression de l'adulte	95 Q	Pr Manoudi
4	Troubles bipolaires	74 Q	Pr Manoudi
5	Troubles des conduites (alimentaires & sexuelles)	55 Q	—
6	Addictions & alcoolisme	44 Q	Pr Manoudi
7	Trouble panique	36 Q	Pr Ag M.A. Laffinti
8	Trouble stress post-traumatique (TSPT)	32 Q	Pr Ag M.A. Laffinti
9	Troubles psychiques grossesse & post-partum	31 Q	Pr I. Adali
10	Trouble obsessionnel-compulsif (TOC)	25 Q	Pr Ag M.A. Laffinti
11	Troubles phobiques	25 Q	Pr Ag M.A. Laffinti
12	Trouble anxieux généralisé (TAG)	21 Q	Pr Ag M.A. Laffinti
13	Comorbidités neuro-organiques & divers	16 Q	—

PARTIE 2 — MOYENNE DE QUESTIONS PAR LEÇON PAR EXAMEN

Statistiques calculées sur 15 sessions, chaque examen ~50 questions.

Leçon officielle	Total	Moy/exam	% d'exam
Thérapeutique (psychotropes)	116	7.73	15.5%
Patient qui délire	101	6.73	13.5%
Dépression de l'adulte	95	6.33	12.7%
Troubles bipolaires	74	4.93	9.9%
Troubles des conduites	55	3.67	7.3%
Addictions & alcoolisme	44	2.93	5.9%
Trouble panique	36	2.40	4.8%
TSPT	32	2.13	4.3%
Grossesse & post-partum	31	2.07	4.1%
TOC	25	1.67	3.3%
Troubles phobiques	25	1.67	3.3%
TAG	21	1.40	2.8%
Comorbidités neuro-organiques & divers	16	1.07	2.1%
TOTAL leçons couvertes par le cours AIO	671 Q	44.7	89.5%

PARTIE 3 — QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES (ORDRE STRICT PAR RANG)

Format : faits (-) / pièges (Δ) / source (□) / lien cours (□) / citations (□)

[RANG 1] THÉRAPEUTIQUE — PSYCHOTROPES

Pharmacologie / Psychiatrie • ~7.73 Q/examen

□ Le plus gros pourvoyeur de questions : ATD, ATP, BZD, hypnotiques, thymorégulateurs, ECT, TCC. Beaucoup de cas cliniques RÉCURRENTS quasi à l'identique.

Antidépresseurs (ATD) — neurotransmission & classes :

- Qualifiés de THYMOANALÉPTIQUES par Delay & Deniker
- Action = ↑ des concentrations intra-synaptiques des monoamines + effet alpha-adrénolytique + anticholinergique + antihistaminique
- ISRS : Fluoxétine, Paroxétine, Sertraline, Escitalopram — IRSNa : Venlafaxine — Imipraminiques/tricycliques : Clomipramine, Amitriptyline
- Sérotonine (5-HT) = humeur, anxiété, agressivité, impulsivité, activité motrice, versant somatique ; Dopamine = catécholamine
- Effets possibles : antidépresseur, anxiolytique, sédatif ET stimulant (selon molécule)
- Δ Δ Clomipramine (Anafranil) n'est PAS un ISRS (c'est un tricyclique) — piège récurrent
- Δ Δ « action anti-dopaminergique D2 » = FAUX pour les ATD (c'est le mécanisme des ANTIPSYCHOTIQUES). NB : la correction officielle de Jan2022 Q43 retient C seul, ce qui contredit la pharmacologie correcte rappelée en Jun2024/Nov2024 (A,B,D,E)
- Δ Δ Effet « antimaniaque » des ATD = FAUX (au contraire : risque de virage maniaque)

□ Vu : N2025 Q43-46, Jun2024 Q47-48, Jan2018 Q5, Jan2022 Q43 (≥8×)

ATD — modalités de prescription (cas clinique EDM récurrent) :

- ISRS en 1ère intention : Sertraline 50–200 mg/j · Escitalopram 10–20 mg/j · Fluoxétine/Paroxétine 20 mg/j
- Durée du traitement après efficacité = 12 mois
- Décroissance progressive sur 6–8 semaines pour éviter le syndrome de discontinuation
- Adjuvant pour l'anxiété = anxiolytique (Alprazolam / Bromazepam)
- Si aggravation sévère avec idées suicidaires → hospitalisation + tricyclique (Clomipramine) ± neuroleptique sédatif (Lévomépromazine) pour l'agitation
- Δ Δ CI absolue des imipraminiques/tricycliques = adénome/hypertrophie de la PROSTATE (aussi : glaucome à angle fermé, cardiopathie décompensée)
- Δ Δ Effet II le plus redouté des ISRS = dysfonction sexuelle
- Δ Δ Délai d'action des ATD = 3–4 semaines (PAS 2 jours) ; durée totale EDM ≠ 3 mois

□ Vu : Jan2023 Q43-50, Jun2021/Jun2023 Q38-50, N2026 Q43-46, Oct2024 Q43-50 (≥10×)

Antipsychotiques (ATP) / Neuroleptiques — classes & mécanisme :

- 1ère génération / classiques : Halopéridol, Chlorpromazine, Lévomépromazine (Nozinan), Sulpiride
- 2ème génération / atypiques : Olanzapine, Risperidone, Clozapine, Aripiprazole, Palipéridone, Quétiapine
- Antagonisme dopaminergique D2 → effet antipsychotique + effet endocrinien + effet extrapyramidal
- Δ Δ Effets extrapyramidaux (akathisie, dyskinésie, sd parkinsonien) surtout avec les CLASSIQUES
- Δ Δ Syndrome métabolique (surpoids, diabète) surtout avec les ATYPIQUES
- Δ Δ Allongement du QT avec TOUS les neuroleptiques
- Δ Δ Effet secondaire endocrinien principal des atypiques = DIABÈTE

□ Vu : Jan2019 Q22, Jan2020 Q26, Jan2024 Q48, Jun2024 Q49, N2025 Q47 (≥8×)

ATP — surveillance & bilan pré-thérapeutique :

- Bilan pré-thérapeutique = éliminer les CI + bilan lipidique + glycémie + recherche des FdR cardiovasculaires
- Effets anticholinergiques à rechercher = sécheresse buccale + constipation

- Règles : privilégier la MONOTHÉRAPIE + surveillance régulière
- ⚠️ *Surpoids/diabète = effet métabolique (PAS anticholinergique) ; hyperprolactinémie = endocrinien (PAS anticholinergique) ; sd parkinsonien/dyskinésie = extrapyramidal*
- ⚠️ *Ne PAS prescrire dose maximale d'emblée, ni correcteurs anticholinergiques systématiques, ni privilégier la voie injectable*
- ⚠️ *Pas de TDM cérébrale ni de bilan thyroïdien dans le bilan pré-NL*

□ Vu : Jan2021 Q44, Jun2021/Jun2022 Q43-46, Jan2024 Q49, N2025 Q48 (≥9×)

Syndrome malin des neuroleptiques :

- Impose l'ARRÊT IMMÉDIAT des neuroleptiques
- Potentiellement mortel — évolution rapidement progressive
- Diagnostic clinique ET biologique
- Traitement = Bromocriptine (agoniste dopaminergique)
- FdR = posologies fortes, températures externes élevées, ATCD de syndrome malin
- ⚠️ *Ne peut PAS être traité en ambulatoire (urgence)*
- ⚠️ *Ne PAS prescrire : Lithium, anticonvulsivants, neuroleptiques, Halopéridol*

□ Vu : Jan2018 Q42, Jan2019 Q34, Jan2020 Q41 (3×)

Anxiolytiques (benzodiazépines) :

- Effets caractéristiques = sédatif, myorelaxant, hypnotique, anxiolytique, amnésiant
- Demi-vie BRÈVE = Alprazolam (Xanax) ; demi-vie LENTE = Clorazépate (Tranxène), Prazépam (Lysanxia), Diazépam (Valium)
- Anxiolytiques NON-BZD : Buspirone (Buspar), Hydroxyzine (Atarax), Étifoxine (Stresam)
- Effets II = troubles de la vigilance, dépendance, phénomène de rebond ; durée max ≈ 12 semaines
- ⚠️ *Effet « antidépresseur » et effet « confusionnel » ne font PAS partie des effets caractéristiques des BZD (pièges classiques)*
- ⚠️ *Pas de « virage maniaque » ni d'« attaque de panique » comme effet II direct*

□ Vu : Jan2018 Q16-17, Jan2019 Q17-18, Jan2020 Q15, Jan2022 Q48 (≥6×)

Hypnotiques (cas clinique récurrent quasi identique) :

- CI ABSOLUE à rechercher avant prescription = insuffisance respiratoire sévère
- Durée maximale de prescription = 2–3 semaines
- Zolpidem (Stilnox) → effet indésirable redouté = AMNÉSIE
- Molécule alternative = Lévomépromazine (Nozinan)
- ⚠️ *La CI absolue n'est PAS l'insuffisance rénale / cardiaque / hématologique / métabolique (piège répété à chaque session)*

□ Vu : Jan2021 Q38-41, Jun2023/Jun2024 Q43-46, Jan2024 Q43-44, N2026 Q47-49 (≥7×)

Thymorégulateurs :

- Classes = Lithium (Théralite) + anticonvulsivants (Valproate/Dépakine, Carbamazépine, Lamotrigine) + antipsychotiques atypiques (Quétiapine, Olanzapine, Risperidone, Aripiprazole)
- Mécanismes du Lithium = antagoniste dopaminergique + action rénale + ↓ libération des catécholamines + facilite le GABA + facilite la neurotransmission sérotoninergique
- CI du Lithium = insuffisance rénale grave, association aux AINS, désordres hydro-électrolytiques
- ⚠️ *Quétiapine, Lithium, Risperidone, Aripiprazole NE sont PAS des anticonvulsivants — seuls Lamotrigine, Valproate et Carbamazépine le sont*

□ Vu : Jan2020 Q14, Jan2021 Q42, Jan2022 Q47, Jun2022 Q47, Jan2024 Q50 (≥6×)

Sismothérapie (ECT) :

- Mécanisme = ↑ plasticité cérébrale + ↑ BDNF (facteur neurotrophique) + effet anticonvulsivant
- Réalisée sous anesthésie générale
- Bilan pré-thérapeutique = EEG + ECG
- ⚠️ *N'inhibe PAS la neurotransmission dopaminergique ni sérotoninergique*

□ Vu : Jun2021 Q44-45, Jan2022 Q50, N2025 Q49 (4×)

Psychothérapie — Thérapie cognitivo-comportementale (TCC) :

- Agit sur le SYMPTÔME (pas sur la personnalité)
- But = déconditionnement du patient
- Thérapie à COURT terme (3–4 mois), directive
- **⚠ ⚠ N'utilise PAS l'hypnose ; n'agit pas sur la personnalité**

□ Vu : Jun2021/Jun2022/Jun2023 Q14/Q19 (≥4×)

[RANG 2] PATIENT QUI DÉLIRE — APA, SCHIZOPHRÉNIE, DÉLIRES CHRONIQUES, HYSTÉRIE

— • ~6.73 Q/examen

□ Regroupe 4 cours : Accès psychotique aigu (APA/BDA), Schizophrénie, Délires chroniques non dissociatifs, Hystérie/conversion.

Accès psychotique aigu (APA / bouffée délirante aiguë) :

- Début AIGU/brutal, évolution IMPRÉVISIBLE, urgence psychiatrique
- Délire POLYMORPHE (mécanismes et thèmes multiples), fluctuations thymiques, dépersonnalisation/déréalisation
- Traitement = antipsychotique atypique en 1ère intention + benzodiazépine pour l'agitation
- Évolue vers : schizophrénie, trouble schizo-affectif, ou délire chronique non dissociatif
- **⚠ ⚠ PAS de début chronique, PAS de thème délirant unique, PAS de délire systématisé**
- **⚠ ⚠ Ne PAS mettre d'emblée sous contention ni dose maximale de NL ; ATD ≠ traitement de l'APA**

□ Vu : Jun2021 Q15-16, Jan2020 Q24-25, Nov2024 Q20-21, Jan2024 Q25 (≥9×)

APA — signes orientant vers une étiologie ORGANIQUE :

- Âge de début TARDIF
- Hallucinations surtout VISUELLES + illusions
- Troubles cognitifs sévères / tableau atypique
- Amélioration par le traitement de l'affection organique causale
- Bilan = TDM cérébrale + recherche de toxiques + bilan de retentissement somatique (NFS, ionogramme)
- **⚠ ⚠ La présence d'ATCD psychiatriques et la bonne réponse aux neuroleptiques NE sont PAS des arguments organiques**

□ Vu : Jan2019 Q33, Jun2022/Jun2023/Jun2024 Q22-23, Jan2024 Q26, Jan2023 Q20-22 (≥8×)

Schizophrénie — clinique & épidémiologie :

- Syndrome caractéristique = syndrome de DISCORDANCE (+ syndrome délirant + syndrome autistique/dissociatif)
- Prévalence ≈ 1 % de la population générale
- Délire schizophrénique = type PARANOÏDE (flou, non systématisé)
- Facteurs de bon pronostic : forme paranoïde, forme schizo-affective, prise en charge précoce
- **⚠ ⚠ Délire PARANOÏAQUE = interprétatif et systématisé (≠ paranoïde de la schizophrénie) — distinction-clé**
- **⚠ ⚠ Prévalence ≠ 2-5 % ; mauvaise adaptation prémorbide = mauvais pronostic**

□ Vu : Jan2018 Q37-39, Jan2020 Q29, Jun2021 Q19, Jan2024 Q27 (≥6×)

Schizophrénie — rôle du médecin généraliste & prodromes & défis :

- MG : dépistage précoce + suivi somatique + promotion de l'hygiène de vie + reconnaissance des rechutes + évaluation de l'observance + travail en réseau avec le psychiatre
- Prodromes = NON spécifiques (troubles cognitifs, manque de motivation, troubles du comportement) → problème de dépistage, confusion possible avec une crise d'adolescence
- Défis de la PEC = absence d'insight, mauvaise observance/arrêt fréquent, abus de substances, rechutes fréquentes, manque de soutien de l'entourage
- **⚠ ⚠ Les prodromes ne sont PAS un syndrome dissociatif ou délirant « manifeste » ; ils ne sont PAS spécifiques**
- **⚠ ⚠ Le MG n'a PAS pour rôle la PEC des formes résistantes ni des rechutes sévères (ressort spécialisé)**

□ Vu : Jan2019 Q19-20, Jan2020 Q28, Jun2022 Q25-26, N2026 Q21-22 (≥12×)

Délires chroniques non dissociatifs (paranoïa, PHC, paraphrénie, érotomanie) :

- Caractéristiques communes : évolution chronique (> 6 mois), ABSENCE de détérioration intellectuelle, ABSENCE de dissociation, mauvaise réponse aux NL, maintien d'un bon fonctionnement, RISQUE MAJEUR de passage à l'acte
- Délire paranoïaque = interprétatif, systématisé, thématique persécutoire, peut entraîner l'adhésion d'autrui, risque médico-légal
- Délire de jalousie = mécanisme interprétatif ; érotomanie = conviction d'être aimé par une personne (souvent inaccessible/célèbre), souvent femme/célibataire, passage à l'acte hétéro-agressif possible
- ⚠️ ⚠️ *PAS de détérioration intellectuelle ni de désorientation (≠ démence) ; PAS de dissociation (≠ schizophrénie)*
- ⚠️ ⚠️ *Érotomanie ≠ délire d'infidélité (= jalousie) ; ne PAS confondre les thèmes*

□ Vu : Jan2019/Jan2020 Q27-28/37-38, Nov2024 Q30-31, N2025 Q22-24, Jan2024 Q24 (≥10×)

Hystérie / Trouble de conversion :

- Conversion = symptômes moteurs + sensitivo-sensoriels + neurovégétatifs (touche la vie de relation)
- Douleurs conversives = 70 % des symptômes conversifs, expression théâtrale, impotence fonctionnelle importante, NE perturbent PAS le sommeil
- Hystérie : altération du fonctionnement socio-professionnel, bénéfices primaires et secondaires, comorbidités psychiatriques fréquentes
- PEC = éliminer une cause somatique d'abord + reconnaître la réalité de la plainte + attitude neutre/bienveillante/empathique + ne pas médicaliser à outrance + ATD si dépression associée + isoler la patiente en crise
- ⚠️ ⚠️ *FAUX : conversion « d'origine organique » ou « conflit conscient » ; prédominance masculine (c'est l'inverse)*
- ⚠️ ⚠️ *Pas d'éther/gifles, pas d'anxiolytique au long cours, pas d'hospitalisation systématique, pas de NL injectable*

□ Vu : Jan2018 Q48-49, Jan2020 Q39-40, Jun2021 Q17-18, N2025 Q25-26, N2026 Q28 (≥12×)

Conduites suicidaires (transversal) :

- Ne jamais négliger une idée suicidaire ; ne jamais banaliser la répétition des TS
- Un suicide « réussi » est toujours possible ; toute TS expose à la répétition
- La fréquence des TS signale une souffrance psychique ; l'attitude négative du médecin peut précipiter le passage à l'acte

□ Vu : N2026 Q11, Jun2021 Q7, Jun2024 Q15 (≥3×)

[RANG 3] DÉPRESSION DE L'ADULTE

Pr Manoudi • ~6.33 Q/examen

□ États dépressifs. Cas clinique d'EDM + virage maniaque sous ATD = matrice récurrente à chaque session.

Épisode dépressif majeur (EDM) — diagnostic :

- Tableau type : tristesse, insomnie (ou hypersomnie + réveil matinal précoce), anhédonie, idées noires, culpabilité, anxiété, asthénie, isolement, ralentissement (évolution > 2 semaines/1 mois)
- Symptômes associés = anxiété, asthénie, plaintes somatiques, idées délirantes, troubles sexuels, hypersomnie/insomnie
- Souffrance morale = idées suicidaires + sentiment d'indifférence/d'abandon + culpabilité + vision pessimiste de soi
- Tristesse dépressive = persistante, incontrôlable, peu accessible au raisonnement, envahit tous les champs, impotence fonctionnelle
- ⚠️ ⚠️ *« Fuite des idées » et « projets multiples » = symptômes MANIAQUES, PAS dépressifs (piège répété)*
- ⚠️ ⚠️ *Plaintes somatiques NON améliorées par les antalgiques (mais améliorées par les ATD), variables, inexpliquées par une cause organique*

□ Vu : N2026 Q1-2, Jan2018 Q1, Jan2024 Q4-5, Nov2024 Q4-5, Jan2022 Q7-8 (≥12×)

Bilan avant traitement — rechercher la BIPOLARITÉ (capital) :

- Rechercher SYSTÉMATIQUEMENT : idées suicidaires actuelles + ATCD personnel d'accès maniaque/hypomaniaque + ATCD familiaux de trouble de l'humeur/bipolaire + ATCD de TS + hallucinations congruentes à l'humeur
- Pourquoi : un ATCD maniaque change la prescription (risque de virage sous ATD)
- ⚠️ Les ATD sont CONTRE-INDIQUÉS dans l'accès maniaque

□ Vu : Jan2018 Q3, Jan2019 Q2, Jan2021 Q6, Jun2022 Q11, Jun2024 Q3 (≥8×)

Évolution & complications :

- Sous traitement : rémission, guérison, récurrence, rechute, chronicité, OU virage maniaque
- Sans traitement : conduites suicidaires, conduites addictives, récurrence, chronicité
- Risque de récurrence : 50 % après le 1er épisode · 70 % après le 2e · 90 % après le 3e
- À surveiller : passage à l'acte suicidaire, virage maniaque, non-réponse, acte médico-légal, fugue, syndrome malin
- ⚠️ L'évolution vers une SCHIZOPHRÉNIE n'est PAS une complication de l'EDM (piège quasi systématique)

□ Vu : Jan2019 Q7-8, Jan2020 Q8, Jan2023 Q5-6, Jun2024 Q8-9 (≥12×)

Formes cliniques : mélancolie, dépression délirante, dysthymie :

- MÉLANCOLIE = EDM d'intensité TRÈS SÉVÈRE : anhédonie généralisée, aréactivité aux stimuli agréables, réveil matinal précoce, culpabilité excessive, angoisses de mort
- DÉPRESSION DÉLIRANTE = humeur dépressive + délire (culpabilité, persécution, syndrome de Cotard, ensorcellement) → CAT : hospitalisation + NEUROLEPTIQUE + ANTIDÉPRESSEUR + bilan ; surveiller suicide/médico-légal/fugue
- DYSTHYMIE = dépression chronique de faible intensité, comorbidité importante, traitée par ATD
- Indications d'hospitalisation = mélancolie, risque suicidaire, quand c'est mieux pour le patient
- ⚠️ Mélancolie ≠ intensité modérée ; dysthymie ≠ intensité sévère
- ⚠️ Dans la dépression délirante, l'ATD SEUL ne suffit pas → toujours associer un NL

□ Vu : Jun2021 Q6, Jun2023 Q6, Jan2024 Q1-2, Jun2024 Q1-2, Nov2024 Q1-2, Jan2023 Q1-2 (≥12×)

Virage maniaque sous antidépresseur (séquence récurrente) :

- Après quelques jours d'ATD : patient excité, euphorique, logorrhéique, dépenses exagérées, délire mégalomane/persécution → VIRAGE MANIAQUE
- CAT = ARRÊTER l'antidépresseur + hospitaliser + mettre sous neuroleptique + thymorégulateur
- Ce tableau révèle un trouble bipolaire (parfois noté « type III » = bipolarité induite par les ATD)
- ⚠️ Ne PAS poursuivre/ré-augmenter l'ATD ; le diagnostic n'est ni schizophrénie ni syndrome malin

□ Vu : Jun2022 Q3-4, Jan2023 Q3-4, Jun2023 Q4-5 (≥6×)

Étiopathogénie & épidémiologie :

- Facteurs = vulnérabilité génétique + événements de vie stressants + baisse des neurotransmetteurs + DIMINUTION du BDNF + personnalité
- Prévalence de l'EDM au Maroc (étude 2014) = 26,5 %
- Dépression chez l'alcoolique : ↑ hospitalisations, potentialise le risque suicidaire, principalement secondaire, liée à la ↓ sérotonine
- ⚠️ C'est la DIMINUTION du BDNF (pas l'augmentation) qui est en cause

□ Vu : Jan2021 Q9, Jan2022 Q5-6, Jan2022/Jan2023 Q14 (≥6×)

[RANG 4] TROUBLES BIPOLAIRES

Pr Manoudi • ~4.93 Q/examen

□ Cas récurrent : agitation maniaque délirante → diagnostic différentiel organique (neurosyphilis, tumeur frontale, APA toxique) avant de retenir le TB.

Accès maniaque — clinique :

- Insomnie SANS fatigue + hypersexualité + dépenses exagérées + logorrhée + exaltation de l'humeur + projets multiples + contact familial et hautain
- Souvent : délire mégalomane + délire de persécution, hypersyntonie, désinhibition, hétéro-agressivité
- ⚠️ « humeur triste », « ralentissement psychomoteur », « bradypsychie » = dépressifs, PAS maniaques
- ⚠️ « anecdote/anhédonie » (terme parfois mal orthographié dans les sujets) ≠ signe de manie

□ Vu : N2026 Q4, Jun2021 Q8, Jun2022 Q8, Jan2018 Q4 (≥6×)

Diagnostic différentiel de l'agitation maniaque délirante (cas récurrent) :

- Évoquer : trouble bipolaire + APA post-toxique + NEUROSYPHILIS + TUMEUR cérébrale frontale + ivresse pathologique
- Bilan = TDM/IRM cérébrale + TPHA/VDRL + recherche de toxiques (+ NFS, BHE)
- Si bilan NORMAL → retenir le TROUBLE BIPOLAIRE
- Traitement curatif = neuroleptique (atypique) + thymorégulateur + hospitalisation
- ⚠️ « aucun bilan » = FAUX devant un 1er épisode (toujours éliminer l'organique)
- ⚠️ Pas d'ATD dans l'accès maniaque

□ Vu : Jan2019 Q10-13, Jan2020 Q1-4, Jan2021 Q1-4, Jan2022 Q1-4, N2026 Q7-10 (≥10×)

Définition & types :

- TB type I = récurrence d'épisodes de MANIE (avec ou sans épisodes dépressifs) — l'épisode maniaque suffit
- Sous thymorégulateur : ↓ fréquence + ↓ intensité + ↓ durée des accès, voire disparition totale
- ⚠️ TB type I ≠ « épisodes dépressifs uniquement » ni « hypomanie + dépression » (ça c'est le type II)

□ Vu : N2026 Q3, Jan2022 Q10, Jun2021 Q9 (≥4×)

Risques, évolution & facteurs de gravité :

- Risques de la manie = désinsertion socio-professionnelle + rapports sexuels non protégés + addictions + dilapidation du capital financier
- TB non traité → ↑ fréquence des accès + TS + actes médico-légaux + addiction + ruine économique
- Facteurs de gravité = symptômes NON congruents à l'humeur + comorbidité addictive + utilisation itérative d'ATD
- ⚠️ L'évolution vers une schizophrénie n'est PAS un risque de la manie
- ⚠️ Il faut RECHERCHER l'hypomanie (non rapportée spontanément, perçue comme avantageuse) car elle oriente vers le TB

□ Vu : Jan2021 Q11, Jun2022 Q7/Q9, Jan2022 Q11, N2026 Q6 (≥6×)

[RANG 5] TROUBLES DES CONDUITES — ALIMENTAIRES & SEXUELLES

— • ~3.67 Q/examen

□ Deux cours : Troubles des conduites alimentaires (TCA) et Troubles des conduites sexuelles. Critères DSM-5.

Anorexie mentale — clinique & formes :

- Triade : restriction alimentaire + lutte active contre la faim + amaigrissement ; + aménorrhée + hyperactivité physique + sélection des aliments selon valeur énergétique + anxiété face à l'alimentation
- Formes cliniques = masculine + de l'adulte + prépubère + avec boulimie
- Évolution = chronicité, troubles anxio-dépressifs, addictions, complications somatiques, TS
- Nécessite souvent l'hospitalisation ; cause de mortalité par complications somatiques
- ⚠️ PAS de surpoids ; n'est PAS « traitée efficacement par les ATD » seuls

□ Vu : N2026 Q16, Jan2022 Q24, Jun2022 Q28, Jan2020 Q34, Jun2021 Q23 (≥8×)

Bilan paraclinique de l'anorexie & complications somatiques :

- But du bilan = apprécier le retentissement de la dénutrition + chercher les troubles de la croissance (prépubères) + mettre en évidence les conséquences du déficit œstroprogestatif

- Complications = dénutrition + déficit hormonal œstroprogestatif + ostéoporose + infertilité + troubles de la croissance
- **⚠ Le bilan ne sert NI à poser le diagnostic positif (clinique) NI uniquement à éliminer les diagnostics différentiels**

□ Vu : N2026 Q17, N2025 Q28, Jan2023 Q26 (≥4×)

Boulimie & hyperphagie boulimique (binge eating) :

- Crise de boulimie = grande quantité d'aliments, caractère impulsif/irrésistible, vomissements provoqués, sentiment de malaise final
- BOULIMIE = comportements compensatoires PRÉSENTS + complications des vomissements + poids NORMAL
- HYPERPHAGIE boulimique = frénésie alimentaire + perte de contrôle + préoccupations pour le poids, SANS comportements compensatoires → SURPOIDS
- **⚠ Distinction-clé : hyperphagie = PAS de compensation, surpoids ; boulimie = compensation, poids normal (vomissements). Ne PAS inverser**

□ Vu : N2026 Q18, N2025 Q27, Jan2018 Q44, Jan2021 Q25-26, Jan2023 Q27 (≥10×)

Conduites sexuelles — abord en consultation & dysfonctions :

- Aborder « santé sexuelle » plutôt que « sexualité », termes simples et précis, détecter les non-dits, sans jugement, sur le registre médical
- Quand aborder : à la demande, puberté, ménopause, grossesse/post-partum, FdR cardiovasculaires
- Dysfonctions masculines = éjaculation retardée + éjaculation prématurée + trouble de l'érection
- Rôle du MG = dépistage + éducation/information + encourager la communication du couple + traiter selon ses compétences
- Problèmes sexuels « silencieux » à évoquer chez : diabète, HTA, coronaropathie, traitement antihypertenseur
- **⚠ Le MG ne doit PAS « traiter tous les troubles sexuels » (selon compétences)**
- **⚠ Paraphilies (intérêts vers objets, circonstances étranges, tort à autrui) ≠ dysfonctions sexuelles**

□ Vu : N2026 Q19-20, Jan2020 Q35-36, Jan2019 Q25-26, Jun2022 Q29-30 (≥8×)

[RANG 6] ADDICTIONS & ALCOOLISME

Pr Manoudi • ~2.93 Q/examen

□ Deux cours : Addictions aux produits + Alcoolisme. Critères DSM-5 du trouble de l'usage.

Généralités : neurotransmetteur, facteurs de risque & de protection :

- Neurotransmetteur du PLAISIR impliqué dans l'addiction = DOPAMINE
- FdR individuels = facteurs génétiques + biologiques + comorbidités psychiatriques + faible estime de soi + haut niveau de recherche de nouveauté + traits de personnalité + événements de vie
- Facteurs de PROTECTION = niveau d'intelligence élevé + capacité à résoudre les problèmes + compétence sociale + estime de soi satisfaisante + soutien familial adapté
- Critères DSM-5 du trouble de l'usage = tolérance + sevrage + quantité/durée > prévu + désir persistant d'arrêter (efforts infructueux) + craving

□ Vu : N2026 Q12-13, Jan2018 Q18, Jan2023 Q12-13, Nov2024 Q11 (≥8×)

Cannabis :

- Troubles neuropsychiatriques = état sub-confusionnel + atteinte des facultés cognitives + accès psychotique aigu + attaque de panique + dépersonnalisation + réactions paranoïaques
- Syndrome AMOTIVATIONNEL = asthénie intellectuelle + perturbations cognitives + pensée floue + difficultés mnésiques + rétrécissement de la vie relationnelle
- **⚠ La SCHIZOPHRÉNIE comme conséquence directe du cannabis est le plus souvent comptée FAUSSE dans ces QE (le cannabis est un facteur de risque, pas une cause directe) — vérifier la formulation**

□ Vu : N2025 Q14, Jun2023 Q15, Jan2019 Q15, Jun2021 Q11, Jun2024 Q10 (≥9×)

Delirium tremens & sevrage alcoolique :

- Delirium tremens = urgence médico-psychiatrique + état confuso-déirant + dû à un sevrage COMPLET d'alcool / alcoolisation massive + signes neurologiques + perturbations hydro-électrolytiques
- Nécessite une réhydratation MASSIVE (5–6 L/jour)
- Prévention/traitement du sevrage = BENZODIAZÉPINES ; traitement du DT = neuroleptique + benzodiazépine
- Complications du sevrage brutal = syndrome de sevrage + crises convulsives + delirium tremens
- ⚠️ ⚠️ Réhydratation « de 2 L/jour » = FAUX (insuffisante → piège systématique)
- ⚠️ ⚠️ Sevrage ≠ traité par NL/lithium/ATD seuls ; les BZD sont la base

□ Vu : N2025 Q15, Jan2018 Q13-15, Jan2020 Q18, Jun2021 Q13, Jun2024 Q14 (≥10×)

Ivresses, coma & syndromes de sevrage spécifiques :

- 4 formes d'ivresse pathologique = excito-motrice + hallucinatoire + confuso-déirante + avec trouble de l'humeur
- Coma alcoolique = hypotonique + hypotension + mydriase bilatérale aréactive + hypothermie
- Sevrage aux OPIACÉS = agitation anxieuse + mydriase bilatérale + douleurs abdo/lombaires/thoraciques + nausées/diarrhées/vomissements + confusion
- Sevrage aux BENZODIAZÉPINES = crises convulsives + troubles neurovégétatifs + état dépressif + crampes abdominales + faiblesse musculaire
- ⚠️ ⚠️ Coma alcoolique = HYPOglycémie attendue (pas hyperglycémie) ; le coma alcoolique n'est PAS une des 4 ivresses pathologiques

□ Vu : Jun2021 Q12, Jan2024 Q13-14, Nov2024 Q12-14, Jan2022 Q13 (≥7×)

[RANG 7] TROUBLE PANIQUE

Pr Ag M.A. Laffinti • ~2.40 Q/examen

□ Distinguer : attaque de panique (symptôme) / trouble panique (maladie) / agoraphobie.

Attaque de panique (AP) :

- Crise d'angoisse aiguë : début brutal/imprévisible, acmé en < 10 minutes, durée 15–30 min, cède progressivement, peut régresser spontanément
- 3 registres : somatique (palpitations, gêne/oppression thoracique, dyspnée), psychique (sentiment de mort/catastrophe imminente, crainte de perdre le contrôle), comportemental (agitation OU inhibition)
- Peut survenir en dehors de tout trouble anxieux ET au cours de plusieurs troubles anxieux
- ⚠️ ⚠️ Début « lent et progressif » et durée « 1–2 jours » = FAUX (paroxystique, acmé < 10 min)

□ Vu : N2026 Q33, N2025 Q35, Jun2024 Q33, Oct2024 Q40 (≥6×)

Trouble panique (TP) — définition & évolution :

- = Attaques de panique RÉCURRENTES et INATTENDUES + crainte persistante (≥ 1 mois) d'une nouvelle attaque ou modification du comportement
- Fait partie des troubles anxieux ; prédominance féminine (2♀/1♂) ; comorbidité possible avec d'autres troubles anxieux ; peut s'associer à l'agoraphobie
- Peut se compliquer de dépression ; évolution favorable possible sous traitement
- ⚠️ ⚠️ « Touche plus les hommes que les femmes » = FAUX
- ⚠️ ⚠️ 1–2 attaques isolées sans crainte persistante = « attaques de panique » SANS trouble panique ni agoraphobie (ne pas sur-diagnostiquer)

□ Vu : N2026 Q34, Jun2024 Q34, Nov2024 Q35, N2025 Q40 (≥6×)

Traitement du trouble panique :

- Traitement de fond = ANTIDÉPRESSEUR ISRS (en 1ère intention, même sans dépression associée)
- Anxiolytique de COURTE durée possible en début de traitement
- TCC = un des moyens de prise en charge
- ⚠️ ⚠️ Les anxiolytiques NE sont PAS le traitement de fond ; l'ATD tricyclique seul en 1ère intention n'est pas le choix recommandé

- **⚠️** « La psychothérapie n'a pas de place » = FAUX

□ Vu : N2025 Q41, Nov2024 Q35, Oct2024 Q37 (≥3×)

[RANG 8] TROUBLE STRESS POST-TRAUMATIQUE (TSPT / ESPT)

Pr Ag M.A. Laffinti • ~2.13 Q/examen

□ Distinguer chronologiquement : réactions immédiates → état de stress aigu (≤ 1 mois) → TSPT (> 1 mois).

Réactions immédiates & état de stress aigu :

- Réactions immédiates (heures suivant le trauma) = fuite panique + état de sidération + accès confusonoirique + réactions agressives + réaction hystériforme brève
- Dissociation péri-traumatique / « stress dépassé » = altération du vécu (« comme si le corps ne lui appartenait plus »), perte du fil du temps
- État de stress AIGU = symptômes (reviviscences, hypervigilance, insomnie) durant entre 2 jours et 1 mois après le trauma
- **⚠️** « stress adapté » ≠ dissociation péri-traumatique ; la réaction décrite n'est pas un stress « adapté »

□ Vu : Jan2021 Q30-31, Jun2022 Q36-37, Jan2023 Q33-34 (≥6×)

TSPT constitué — clinique :

- Syndrome de RÉPÉTITION = pathognomonique : flashbacks + cauchemars à répétition + le sujet revit l'événement (reviviscences)
- + hypervigilance + insomnie + sursauts ; survient après un événement traumatique vécu avec peur/horreur
- Touche plus de femmes que d'hommes ; prévalence plus élevée chez les combattants ; les manifestations peuvent apparaître immédiatement
- Diagnostic de TSPT si la symptomatologie PERSISTE au-delà d'1 mois (vs stress aigu)
- **⚠️** « Le sujet doit toujours être confronté à SA PROPRE mort » = FAUX (peut être témoin de la mort d'autrui)
- **⚠️** Les cauchemars ne sont pas « obligatoires » au diagnostic ; phase de latence ≠ toujours libre de tout symptôme

□ Vu : Jan2019 Q49, Jan2020 Q46-47, Jan2021 Q32 (≥6×)

Traitement du TSPT :

- Traitement de FOND = antidépresseur (ISRS)
- Psychothérapie = EMDR (désensibilisation par mouvements oculaires)
- Anxiolytique = ponctuel seulement
- **⚠️** L'anxiolytique n'est PAS le traitement de fond ; le NL n'est pas le traitement de fond ; l'EPR (exposition/prévention de réponse) est plutôt pour le TOC

□ Vu : Jun2022 Q39, Jan2021 Q32 (≥2×)

[RANG 9] TROUBLES PSYCHIQUES DE LA GROSSESSE & DU POST-PARTUM

Pr I. Adali • ~2.07 Q/examen

□ Hiérarchie de gravité : baby blues (bénin) « < mélancolie du post-partum » < psychose puerpérale (urgence vitale).

Dépistage (santé publique) :

- Se fait lors des consultations de suivi de grossesse ET des premières semaines du post-partum
- Implique TOUS les intervenants de la santé périnatale (pas uniquement les psychiatres)
- Impose la recherche des facteurs de risque maternels ; doit être une priorité de santé publique

- **⚠️⚠️** « Implique uniquement les psychiatres » / « uniquement à la demande de la parturiente » = FAUX

□ Vu : Jan2019 Q23, Jan2020 Q30, Jun2023/Jun2024 Q20, Jan2021 Q16 (≥6×)

Baby blues vs mélancolie du post-partum :

- BABY BLUES (blues du post-partum) = labilité de l'humeur, transitoire, BÉNIN (≈ J3, résolutif spontanément en quelques jours)
- MÉLANCOLIE du post-partum = angoisses de mort massives + délire centré sur le bébé + labilité de l'humeur (EDM sévère)
- Troubles du 1er trimestre = modifications des conduites alimentaires + inquiétudes liées à la grossesse + labilité émotionnelle
- **⚠️⚠️** Le baby blues n'est PAS un épisode dépressif caractérisé, ni un deuil, ni la cause obligatoire de maltraitance
- **⚠️⚠️** Baby blues et psychose puerpérale sont des troubles du POST-PARTUM (pas du 1er trimestre)

□ Vu : Jan2023 Q25, Jan2020 Q31, Jan2021 Q15 (≥4×)

Psychose puerpérale (du post-partum) — URGENCE :

- Urgence DIAGNOSTIQUE et THÉRAPEUTIQUE ; impose l'hospitalisation en urgence en milieu psychiatrique
- Complications redoutables = SUICIDE + INFANTICIDE
- Tableau (≈ J2-J3) : délire (souvent centré sur le nouveau-né), agitation, comportement désorganisé, insomnie totale, patiente souvent euthymique
- Toujours ÉLIMINER une cause organique d'abord (ex. thrombophlébite cérébrale → angio-IRM) ; CAT = hospitalisation + neuroleptiques antiproductifs + sédatif (± ECT si résistance)
- **⚠️⚠️** « Trouble léger et transitoire » / « spontanément résolutif en 4-7 jours » = FAUX (c'est le baby blues)
- **⚠️⚠️** Ne survient PAS pendant la grossesse, n'est PAS une réaction normale à l'accouchement

□ Vu : Jan2019 Q24, Jan2022 Q31, Jun2022 Q20-22, Jan2024 Q20-22, Jun2024 Q21 (≥10×)

[RANG 10] TROUBLE OBSESSIONNEL-COMPULSIF (TOC)

Pr Ag M.A. Laffinti • ~1.67 Q/examen

□ Piège transversal : la « phobie d'impulsion » est une OBSESSION (TOC), pas une vraie phobie.

Définition & épidémiologie :

- = présence d'OBSESSIONS et/ou de COMPULSIONS ; touche autant les hommes que les femmes
- Peut débuter dès l'enfance/adolescence ; diagnostic souvent RETARDÉ (après des années)
- Critères : perte de temps considérable + souffrance significative ; éliminer une cause organique/psychiatrique d'abord
- Ne fait PLUS partie des troubles anxieux dans les classifications récentes (DSM-5)
- **⚠️⚠️** « Demande de soin précoce » = FAUX (diagnostic tardif)
- **⚠️⚠️** Les pensées intrusives sont des OBSESSIONS, pas des compulsions ; les compulsions/rituels sont les ACTES répétés

□ Vu : Jan2021 Q33, Jan2022 Q41, Jun2024 Q39, Nov2024 Q33, N2025 Q34 (≥8×)

Obsessions, compulsions & rituels :

- Obsessions IDÉATIVES = idée/image mentale, doute, interrogation, crainte obsédante
- Obsessions PHOBiques = crainte de commettre un acte absurde/violent contre sa volonté (« phobie d'impulsion ») ; la peur existe même en dehors de l'objet
- Compulsions/rituels = actes répétés (lavages, vérifications) ; vérifications ↔ obsessions de doute
- Le sujet reconnaît le caractère pathologique ET que les idées émanent de sa PROPRE activité psychique ; lutte anxieuse associée
- **⚠️⚠️** « Les obsessions sont extérieures à sa propre activité psychique » = FAUX (ça orienterait vers une hallucination/automatisme)
- **⚠️⚠️** La « phobie d'impulsion » et l'« obsession phobique de contamination → lavages » relèvent du TOC (pas des phobies spécifiques)

□ Vu : Jan2020 Q50, Jun2023 Q37-38, Jun2024 Q38, Nov2024 Q38-39, N2026 Q29-31 (≥8×)

Traitement du TOC :

- Traitement de fond = ISRS, à doses souvent IMPORTANTES, sur durée prolongée
- Psychothérapie = TCC avec EXPOSITION et PRÉVENTION de la RÉPONSE (EPR)
- Adjuvant = antipsychotique ; neurochirurgie parfois (formes résistantes)
- ⚠ ⚠ *Délai d'action des ISRS dans le TOC = lent (PAS rapide) ; durée du traitement ≠ limitée à 3 mois*

□ Vu : Jan2021 Q34, Jan2022 Q42, Jun2023 Q40, N2026 Q32 (≥5×)

[RANG 11] TROUBLES PHOBQUES

Pr Ag M.A. Laffinti • ~1.67 Q/examen

□ 3 entités : agoraphobie, phobies spécifiques, phobie sociale (anxiété sociale).

Définition & types :

- Symptôme cardinal = peur DISPROPORTIONNÉE, déclenchée EN PRÉSENCE de l'objet/situation phobogène ; le sujet est CONSCIENT du caractère pathologique
- Conduites d'évitement (situationnel/subtil) qui soulagent momentanément mais RENFORCENT/chronicisent le trouble
- Troubles phobiques = agoraphobie + phobies spécifiques + phobie sociale (anxiété sociale)
- Phobies spécifiques : sang (hématophobie), hauteurs (acrophobie), insectes, animaux, orages, souris (musophobie)
- ⚠ ⚠ *La peur n'existe PAS en l'absence de l'objet (≠ obsession phobique du TOC) ; l'objet n'est PAS objectivement dangereux*
- ⚠ ⚠ *Les « phobies d'impulsion » et les « obsessions phobiques » NE font PAS partie des troubles phobiques (= TOC)*

□ Vu : N2026 Q35-36, Jun2024 Q35-37, Jan2022 Q36, Nov2024 Q40-41 (≥8×)

Cas particuliers & traitement :

- Phobie du SANG → réaction vagale (lipothymie/syncope) ; traitement = technique d'EXPOSITION en TCC (souvent seule)
- PHOBIE SOCIALE (anxiété sociale) = gêne intense au contact d'autrui/regard d'autrui → traitement = ATD ISRS de fond + TCC ; propranolol (Avlocardyl) ponctuel avant les présentations
- AGORAPHOBIE = trouble anxieux ET phobique, durée > 6 mois, situations évitées/subies, peut survenir EN DEHORS du trouble panique, la confrontation peut déclencher une vraie attaque de panique ; ATD de fond
- ⚠ ⚠ *Phobie sociale : pas de benzodiazépine en traitement de fond ; ne pas changer le fond à 2 semaines (délai ATD insuffisant)*

□ Vu : Jan2023 Q37-39, Jun2021 Q33-34/37, N2025 Q37 (≥6×)

[RANG 12] TROUBLE ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE (TAG)

Pr Ag M.A. Laffinti • ~1.40 Q/examen

□ Anxiété « flottante », non liée à un objet/situation précis (≠ phobie, ≠ TOC, ≠ TSPT).

Clinique & diagnostic :

- = état de tension anxieuse PERMANENTE + soucis/préoccupations EXCESSIFS et incontrôlables (santé, travail, famille)
- Anxiété « flottante », non spécifique d'un objet ou d'une situation
- Clinique = tension musculaire + irritabilité + troubles mémoire/concentration + hypervigilance + sentiment d'être « survolté/à bout » + agitation
- Fait partie des troubles anxieux ; comorbidité dépressive fréquente ; peut évoluer sur plusieurs années

- **⚠ ⚠** *Durée requise = 6 mois (DSM-5). NB : une session (Jun2021 Q28) retient « 3 mois », d'autres « 1 mois » — incohérence des corrections ; retenir 6 mois*
- **⚠ ⚠** *Pas d'idées délirantes, pas d'idées intrusives (TOC), pas de cauchemars traumatiques (TSPT), pas de crises paroxystiques (TP)*

□ Vu : N2026 Q37, Jan2023 Q42, Jun2024 Q42, Nov2024 Q34, Jun2022 Q33-34 (≥10×)

Traitement :

- Traitement de fond = ANTIDÉPRESSEUR ISRS ou IRSNa (justifié même en dehors d'une dépression)
- + mesures hygiéno-diététiques ; TCC aussi efficaces que les médicaments
- ISRS indiqués aussi dans : trouble panique, TOC (et TAG)
- **⚠ ⚠** *Le traitement de fond N'est PAS l'anxiolytique (automédication BZD = risque de dépendance)*
- **⚠ ⚠** *« ATD justifié uniquement si dépression associée » = FAUX*

□ Vu : N2025 Q38, Jun2024 Q41, Jun2022 Q35, Jun2023 Q39 (≥5×)

[RANG 13] COMORBIDITÉS NEURO-ORGANIQUES & DIVERS

— • **~1.07 Q/examen**

□ Bloc hétérogène : neurosyphilis, troubles mentaux critiques (épilepsie), troubles psychosomatiques, démences, troubles de la personnalité, épidémiologie nationale.

Neurosyphilis :

- = MÉNINGO-ENCÉPHALITE
- Troubles psychiatriques = troubles de l'humeur + syndrome délirant polymorphe + hallucinations auditives et visuelles + agressivité + désinhibition sexuelle
- Bilan = TPHA/VDRL (dans le diagnostic différentiel d'une agitation délirante)
- **⚠ ⚠** *N'est PAS une démence vasculaire ni une simple confusion mentale*

□ Vu : Jan2018 Q47, Jan2023 Q30 (≥2×)

Troubles mentaux critiques (épilepsie) :

- Caractéristiques = début et fin BRUSQUES + durée BRÈVE + troubles de la vigilance + amnésie post-critique + récurrence sur le même mode
- **⚠ ⚠** *« Début et fin progressifs » = FAUX (brusques)*

□ Vu : N2026 Q26, Jan2018 Q50, Jan2021 Q27, Jan2023 Q32, Jan2024 Q23, Jun2024 Q28 (≥6×)

Troubles psychosomatiques :

- = expression corporelle des tensions psychologiques + atteintes somatiques OBJECTIVABLES + touchent les muscles LISSES et les viscères
- Exemples = HTA, asthme, diabète, hypothyroïdie, maladies de système
- PEC = éviter placebos/traitements symptomatiques + expliquer la nécessité d'une évaluation psychique ET somatique + privilégier approche corporelle/psychothérapies
- **⚠ ⚠** *Ne touchent PAS la musculature volontaire (≠ conversion) ; ne pas demander d'exams exhaustifs ni dire « c'est dans votre tête »*

□ Vu : Jun2021 Q27, Jun2023 Q31-32, N2025 Q32 (≥4×)

Démences, personnalité & épidémiologie :

- Démences = 5 % des sujets > 65 ans ; Alzheimer = la plus fréquente, héréditaire, touche surtout les femmes (forme précoce 45–65 ans)
- Trouble de personnalité = évaluation du fonctionnement interpersonnel + contrôle des impulsions + affectivité + cognition (PAS l'état physique)
- Prévalence des troubles mentaux au Maroc (enquête nationale) = 48,9 %
- **⚠ ⚠** *Alzheimer n'est PAS d'étiologie précise et curable, ne débute pas « toujours après 65 ans »*

□ Vu : Jan2018 Q23/Q45-46, Jan2019 Q31, Jun2022 Q13 (≥4×)

PARTIE 4 — TOPICS HORS LEÇONS OFFICIELLES 2026 (COURS ANNULÉ)

⚠ DISCLAIMER — À LIRE AVANT D'UTILISER CETTE SECTION ⚠

These lessons are NOT in the 2026 exam program.

Cours annulé — NOT officially scheduled.

USE AT YOUR OWN RISK — BUT GOOD TO KNOW.

Ces topics représentaient historiquement ~10.5% des questions des examens passés. S'ils ne sont PAS au programme cette année, ils peuvent malgré tout :

- Apparaître en question résiduelle ou rattrapage
- Être recyclés à la dernière minute
- Servir de "culture générale" médicale

Topics hors programme 2026 (par fréquence décroissante) :

Topic (hors programme)	Total	Moy/exam
Trouble du spectre de l'autisme (TSA)	22 Q	1.47
Dépression de l'enfant et de l'adolescent	16 Q	1.07
TDAH (trouble déficit attention/hyperactivité)	13 Q	0.87
Maltraitance et sévices aux enfants	11 Q	0.73
Difficulté / échec scolaire	9 Q	0.60
Autres pédopsychiatrie (énurésie, TED)	4 Q	0.27
Questions diverses / inclassifiables	3 Q	0.20
Méthodologie (essai randomisé)	1 Q	0.07

[HORS 1] TROUBLE DU SPECTRE DE L'AUTISME (TSA)

22 questions — 1.47 Q/examen (cours pédopsychiatrie non inclus dans le PDF AIO)

Triade autistique & clinique :

- TRIADE = trouble de l'interaction sociale + trouble de la communication verbale et non verbale + comportement répétitif et stéréotypé
- Trouble neurodéveloppemental précoce ; enfant ne cherche pas le contact, langage écholalique, n'apprécie pas les changements, déficit d'attention conjointe et d'imitation
- Signes associés = troubles du sommeil, peurs inexplicables, difficultés alimentaires, problèmes sphinctériens, particularités sensorielles
- FdR = sexe féminin, ATCD familial de TSA, ATCD personnel de retard mental
- ⚠ PAS d'hallucinations, PAS de syndrome dépressif ni délirant dans la triade

□ Vu : N2025 Q16, Jun2024 Q16, Jan2020 Q19-20, Jan2022 Q16 (≥10×)

Dépistage précoce :

- Signes d'alerte ABSOLUE (< 24 mois) = absence de pointage/gestes sociaux à 12 mois + absence de mots à 18 mois + perte du langage et des compétences sociales (à tout âge)
- 1er signe repérable dès 18 mois = difficultés de l'interaction sociale ; utiliser la main de l'adulte comme outil
- M-CHAT-R = échelle de DÉPISTAGE précoce (enfants < 30 mois)
- Dépister sur la fréquence + association + intensité + persistance des symptômes
- ⚠ M-CHAT-R = dépistage, PAS diagnostic positif ni de sévérité

□ Vu : N2026 Q42, Jan2024 Q16, Nov2024 Q16, Jun2021 Q49-50, Jan2021 Q46 (≥6×)

[HORS 2] DÉPRESSION DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT

16 questions — 1.07 Q/examen (cours pédopsychiatrie non inclus dans le PDF AIO)

Particularités & diagnostic :

- 2 symptômes orientant à l'âge enfant = humeur IRRITABLE + perte d'intérêt/plaisir dans les activités
- Sous-évaluée, hétérogénéité clinique, crise à aborder en urgence ; symptomatologie différente de l'adulte et variable selon l'âge/maturation cognitive/affective
- Signes de Spitz (nourrisson > 6 mois) = indifférence à l'entourage, absence de jeux, absence de curiosité exploratrice, retard psychomoteur et du langage
- FdR = génétiques + atteintes somatiques + événements de vie stressants + sévérité éducative + mauvaise qualité des interactions mère-enfant
- ⚠️ ⚠️ *Diagnostic « facile » = FAUX (sous-évaluée) ; ne concerne pas que 10 % des enfants*

□ Vu : N2026 Q41, Jan2018 Q31-32, Jun2022 Q15, Jan2024 Q18 (≥8×)

Traitement :

- Traitement = multimodal : intervention sur l'environnement + approche psychologique (de règle) + mesures institutionnelles parfois
- ⚠️ ⚠️ *Le traitement médicamenteux n'est PAS obligatoire ; approche unimodale = FAUX*

□ Vu : Jan2018 Q32 (≥1×)

[HORS 3] TDAH — TROUBLE DÉFICIT DE L'ATTENTION / HYPERACTIVITÉ

13 questions — 0.87 Q/examen (cours pédopsychiatrie non inclus dans le PDF AIO)

Définition & PEC :

- TRIADE = déficit attentionnel + hyperactivité motrice + impulsivité ; symptôme CARDINAL = déficit de l'attention
- Enfant d'âge scolaire ; prévalence 3–5 % ; diagnostic clinique ; 50–60 % persistent à l'âge adulte ; haute comorbidité psychiatrique
- Symptômes stables dans le temps, présents dans ≥ 2 domaines de vie ; l'enfant change vite d'activité, ne maintient pas un effort soutenu, ne sait pas attendre, mieux en situation duelle
- PEC de 1ère intention = psychoéducation + mesures rééducatives + aménagements scolaires
- ⚠️ ⚠️ *Pas de troubles de la marche/langage ni d'hallucinations dans la triade ; ATD/psychostimulants ≠ 1ère intention*

□ Vu : N2026 Q39, Jun2022 Q17, Jan2023 Q15, Jun2021 Q46-47 (≥8×)

[HORS 4] MALTRAITANCE ET SÉVICES AUX ENFANTS

11 questions — 0.73 Q/examen (cours pédopsychiatrie non inclus dans le PDF AIO)

Repérage, FdR & signalement :

- 2 types les plus fréquents = violences physiques + abus sexuels
- Suspicion de maltraitance physique = lésions MULTIPLES + VARIÉES + d'ÂGES DIFFÉRENTS + topographie inhabituelle
- FdR = âge < 4 ans + enfant à besoins spéciaux / ne répondant pas aux attentes + ATCD de maltraitance chez les parents + difficultés financières + éclatement familial + accès facile à l'alcool/drogues
- Missions du médecin = repérer, évaluer, protéger, signaler (aux autorités compétentes) et soigner ; le signalement est un ACTE MÉDICAL obligatoire
- ⚠️ ⚠️ *« Toute allégation de maltraitance est vraie » = FAUX (mais toute allégation mérite grande attention) ; le signalement ne vise pas à désigner l'auteur*

□ Vu : N2026 Q40, Jan2018 Q21-22, Jan2020 Q23, Jan2024 Q19, N2025 Q17 (≥8×)

[HORS 5] DIFFICULTÉ / ÉCHEC SCOLAIRE & DIVERS PÉDOPSYCHIATRIE

13 questions cumulées — échec scolaire (9), énurésie/TED (4) — non inclus dans le PDF AIO

Échec scolaire :

- Causes : défaut de compétence + manque de motivation + manque de moyens + non-utilisation des moyens + causes psychologiques
- Causes psychologiques = troubles neurodéveloppementaux + dépression + troubles anxieux + TOC + troubles du comportement + TDAH
- Enfant intellectuellement précoce (EIP) = veut savoir, devine vite, complexifie

□ Vu : Jun2024 Q19, Jan2023 Q18, Jan2024 Q17, Jan2018 Q29-30 (≥7×)

Énurésie de l'enfant :

- Causes = hérédité (≈ 80 %) + déficit d'hormone antidiurétique + capacité vésicale réduite + instabilité vésicale + délai de maturation
- Approche motivationnelle = cesser couches, vider la vessie au coucher, restriction hydrique 2 h avant, renforcement positif (calendrier)
- ⚠ ⚠ « Anomalie d'éducation » comme cause et « participation punitive au changement des draps » = FAUX

□ Vu : Jan2018 Q19-20, Jan2019 Q44 (≥3×)

AIDE-MÉMOIRE FINAL — HIGH-YIELD CONCOURS SANTÉ MENTALE (PSYCHIATRIE)

** SEUILS DE DURÉE & DURÉES DE TRAITEMENT À RETENIR **

Attaque de panique	acmé < 10 min, durée 15-30 min
Stress aigu → TSPT	≤ 1 mois → stress aigu ; > 1 mois → TSPT
Trouble panique	crainte persistante ≥ 1 mois
TAG	durée ≥ 6 mois (DSM-5)
Délire chronique non dissociatif	évolution > 6 mois
Hypnotique — durée max	2-3 semaines
Anxiolytique — durée max	≈ 12 semaines
ATD dans l'EDM — durée	12 mois (décroissance 6-8 sem.)
APA — durée du traitement	≈ 2-5 ans
Prévalence : schizophrénie / DT cible	schizo ≈ 1 % ; EDM Maroc 2014 ≈ 26,5 %

** MOLÉCULES & POSOLOGIES-CLÉS **

Marqueur / Critère	Indication
ISRS	Fluoxétine, Paroxétine, Sertraline (50-200 mg/j), Escitalopram (10-20 mg/j)
IRSNa	Venlafaxine (Effexor)
Tricycliques/imipraminiques	Clomipramine (Anafranil), Amitriptyline — CI : adénome prostate
BZD ½-vie brève / lente	brève = Alprazolam (Xanax) ; lente = Diazépam, Prazépam, Clorazépate
Anxiolytiques non-BZD	Buspirone, Hydroxyzine (Atarax), Étifoxine (Stresam)
Hypnotique	Zolpidem (Stilnox) → effet redouté = amnésie
ATP atypiques (2e G)	Olanzapine, Risperidone, Clozapine, Aripiprazole, Palipéridone, Quétiapine
ATP classiques (1e G)	Halopéridol, Chlorpromazine, Lévomépromazine (Nozinan), Sulpiride
Thymorégulateurs	Lithium + anticonvulsivants (Valproate, Carbamazépine, Lamotrigine) + atypiques
Sd malin des NL	traitement = Bromocriptine

** PIÈGES CLASSIQUES DU CONCOURS **

- ⚠ ATD = ↑ monoamines + anticholinergique/antihistaminique/alpha-adrénergique — PAS anti-D2 (= ATP). Clomipramine ≠ ISRS.
- ⚠ ATD CONTRE-INDIQUÉS dans l'accès maniaque ; risque de virage maniaque → toujours rechercher ATCD bipolaires avant de prescrire un ATD.
- ⚠ Dépression : « fuite des idées » et « projets multiples » sont MANIAQUES, pas dépressifs.
- ⚠ Délire PARANOÏDE (schizophrénie, flou/non systématisé) ≠ délire PARANOÏAQUE (interprétatif, systématisé).

- **⚠ Hyperphagie boulimique** = SANS compensation, surpoids ; Boulimie = AVEC compensation/vomissements, poids normal.
- **⚠ « Phobie d'impulsion »** et « obsession de contamination → lavages » = TOC, PAS phobies. Obsessions = émanent du psychisme propre.
- **⚠ Hypnotique** : CI absolue = insuffisance RESPIRATOIRE sévère (pas rénale/cardiaque).
- **⚠ Delirium tremens** : réhydratation MASSIVE 5-6 L/j (« 2 L/j » = piège faux).
- **⚠ Baby blues** = bénin/transitoire ; Psychose puerpérale = urgence (suicide + infanticide).
- **⚠ ESPT** : le sujet n'est PAS obligatoirement confronté à sa propre mort (témoin possible).
- **⚠ Effets extrapyramidaux** → NL classiques ; syndrome métabolique → NL atypiques ; QT long → TOUS.
- **⚠ TCC agit sur le SYMPTÔME** (pas la personnalité), thérapie courte et directive, sans hypnose.

**** ARBRES DÉCISIONNELS & CONDUITES À TENIR ****

- Agitation maniaque délirante → éliminer organique (TDM/IRM + TPHA-VDRL + toxiques) → si normal = TB → NL atypique + thymorégulateur + hospitalisation
- EDM avec idées délirantes (dépression délirante) → hospitalisation + NEUROLEPTIQUE + ANTIDÉPRESSEUR (ATD seul insuffisant)
- Virage maniaque sous ATD → ARRÊTER l'ATD + NL + thymorégulateur + hospitalisation
- APA → antipsychotique atypique + BZD ; rechercher signes organiques (hallucinations visuelles, début tardif, troubles cognitifs)
- Psychose puerpérale → éliminer cause organique (angio-IRM : thrombophlébite) → hospitalisation + NL antiproductifs + sédatif (± ECT)
- Sevrage alcoolique → BENZODIAZÉPINES (prévention DT) ; delirium tremens → NL + BZD + réhydratation massive
- Trouble anxieux (TP, TAG, phobie sociale, TSPT, TOC) → ATD ISRS de FOND + TCC ; anxiolytique court/ponctuel seulement

Généré par Claude.ai (claude-opus-4-8) — Version 1

Cross-match 750 QEs officielles × Cours AIO Santé Mentale 2025-2026 (1212 diapositives)

Pr Manoudi · Pr Ag M.A. Laffinti · Pr I. Adali — FMPM 2026

Améliorations Version 1 :

- ✓ PARTIE 3 strictement par rang de fréquence (1 → 13)
- ✓ Déduplication des questions répétées sur 15 sessions (2018-2026)
- ✓ FAUX/pièges explicites avec **⚠** (contenu à plus haut rendement)
- ✓ Incohérences des corrections officielles signalées (ATD anti-D2, durée TAG)
- ✓ PARTIE 4 = leçons présentes aux examens mais ABSENTES du cours AIO fourni (pédopsychiatrie)
- ✓ Aide-mémoire psychiatrie : seuils de durée, molécules, pièges, arbres décisionnels